

表2 Mclsaac の基準

クライテリア	ポイント
38℃以上の発熱	1
咳嗽なし	1
前頭部リンパ節の腫脹、圧痛	1
扁桃の腫大または滲出物	1
年齢	
3～14 歳	1
15～44 歳	0
45 歳以上	-1

[Mclsaac WJ, et al : JAMA 291 : 1587, 2004 より引用]

ロイド性抗炎症薬、鼻汁、鼻閉に対しては抗ヒスタミン薬、咳嗽に対しては鎮咳薬などによる対症療法を行う場合があるが、特に高齢者では副作用が出やすいので注意が必要である。さらに、安静を保ち、水分および栄養補給、室温や湿度の調節を行うなどの生活指導も行うことが重要である。また、感染拡大防止のために手洗いや咳エチケットの指導も行う。

急性咽頭炎もウイルス性が多く通常は抗菌薬は不要だが、A 群溶連菌性咽頭炎に対しては抗菌薬投与が推奨されており、第一選択として amoxicillin (AMPC) を 10 日間内服投与する⁴⁾。ペニシリンアレルギーがある場合は、第一世代セフェム系内服薬の cefalexin (CEX) や clindamycin (CLDM) を用いる。EB ウイルスによる伝染性単核球症に対してアミノペニシリンを投与すると皮疹が出現することがあるため、注意が

必要である。

急性喉頭蓋炎に対しては ceftriaxone (CTRX) を点滴静注する。さらに本症は、喉頭蓋の腫脹から気道閉塞をきたして致死になる危険性があり、早急に気道確保などの処置が可能な施設への移送が必要である。

Advanced

■上気道感染症に合併する Lemierre 症候群

急性咽頭炎などに合併して、扁桃周囲膿瘍や咽後膿瘍など深部の細菌感染症を発症することがある。Lemierre 症候群もそのひとつであり、主に咽頭炎から副咽頭間隙や頸動脈鞘へ細菌感染による炎症が波及し、内頸静脈の血栓性静脈炎や、さらに肺や全身に敗血症性塞栓を起こす。原因菌は嫌気性菌である *Fusobacterium necrophorum* の頻度が高い。本症の発症はまれではあるが、治療が遅れると予後が不良である。咽頭痛に加えて開口障害や内頸静脈に沿った圧痛などの所見を認める場合には、頭頸部造影 CT や血液培養などで診断し、早期に抗菌薬治療を行う必要がある。

文 献

- 1) 呼吸器感染症に関するガイドライン作成委員会：「呼吸器感染症に関するガイドライン」成人気道感染症診療の基本的考え方、日本呼吸器学会、2003
- 2) Heikkinen T, et al : Lancet 361 : 51, 2003
- 3) Centor RM, et al : Med Decis Making 1 : 239, 1981
- 4) Mclsaac WJ, et al : JAMA 291 : 1587, 2004
- 5) Wong DM, et al : Am Fam Physician 74 : 956, 2006